

INFORME BROTE INTRAHOSPITALARIO POR TOXINA A-B

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
El Susan Trondoso Mora Enfermera Programa Control de Infecciones UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Paulina Antonucci Sotomayor Enfermera encargada Programa Control de Infecciones UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES	HOSPITAL EL CARMEN UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES Dra. Yadira Perez Paraqueimo. Médica Infectólogo Programa Control de Infecciones Ed. Macarena Escobar Armijo Jefa Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente DEPTO. DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE S.S.M.C.	HOSPITAL EL CARMEN DIRECCIÓN S.S.M.C. C. Galvez Lopez Don Cristian Galvez Lopez Director Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Junio a Agosto 2025		

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	3
<i>Detección y diagnóstico de brote</i>	<i>3</i>
<i>Intervenciones realizadas</i>	<i>5</i>
<i>Fechas de Hitos.....</i>	<i>09</i>
<i>Desenlace.....</i>	<i>09</i>
<i>Letalidad</i>	<i>09</i>
CONCLUSIÓN	10
I. ANEXO.....	11

INTRODUCCIÓN

Los brotes epidémicos que se pesquisan durante la vigilancia epidemiológica, estos son reportados de inmediato a la Autoridad sanitaria correspondiente por medios establecidos de acuerdo con el Decreto N° 7 Reglamento sobre Notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. Dichos datos son resguardados por el Programa de control de infecciones

Este informe da a conocer el **agente, fecha de inicio y término, número de casos y expuestos, servicio afectado y curva epidémica, como así, su respectivo análisis de sus causas, intervenciones realizadas y evaluación de su impacto.**

DESARROLLO

Detección y diagnóstico de brote

El día **10 de junio 2025** se pesquisa brote epidémico por infección gastrointestinal por *Clostridioides difficile* (ICD) entre los servicios de Cirugía Especialidades y Medicina 1. Esto dado que hubo un aumento de casos por el agente mencionado 6 en total en 2 semanas, con nexo epidemiológico analizados por PCI.

Se realiza revisión de antecedentes clínicos de los casos positivos con diagnóstico confirmado por *Clostridioides difficile* (ICD), se inicia trazabilidad, y se concluye lo siguiente:

Caso índice

Paciente positivo para TOXINA A-B, tras toma de muestra 10-07-2025, con inicio de sintomatología gastrointestinal 07-07-2025, en sala 441-A exponiendo a 1 paciente como contacto TCD.

Caso primario

Paciente positivo para TOXINA A-B, tras toma de muestra 01-07-2025, con inicio de sintomatología gastrointestinal 28-06-2025 exponiendo a 2 pacientes.

Casos secundarios

Los casos secundarios corresponden a la totalidad de pacientes que, a posterior, y, que presentan nexo epidemiológico con los **casos primario e índice**, presentando sintomatología gastrointestinal y resultado positivo para *Clostridioides difficile*.

El 10 de junio se notifica a Unidad clínica, y se formaliza mediante correo la notificación a Subdirección de Gestión Asistencial (SDGA) (**Anexo 1**).

Tras detección de brote, se notifica a brote mediante plataforma SICARS el día 11 de junio 2025.

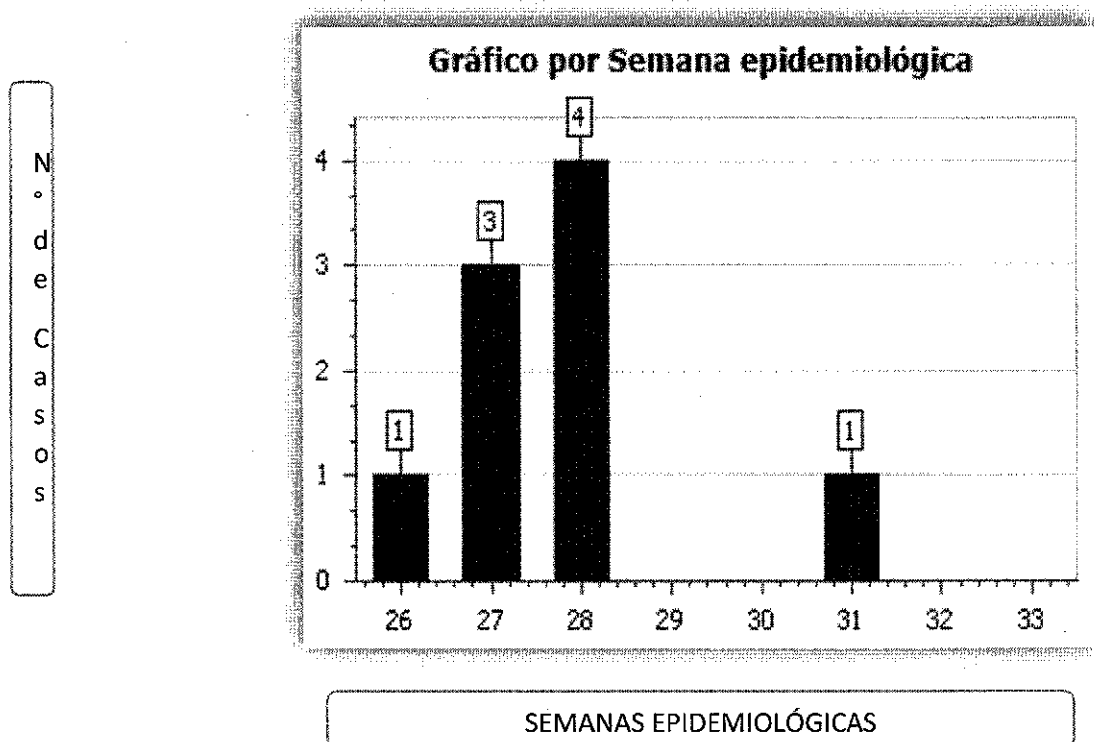
Hipótesis: Quiebre de normativa relacionada con la prevención de IAAS en relación con la ejecución de precauciones estándares y adicionales, en la atención de pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía especialidades, Medicina 1 y Cirugía general I.

Definición de caso: Pacientes que ingresan a la Unidad de Cirugía especialidades, Medicina 1 y Cirugía general I, sin diagnóstico de infección gastrointestinal asociada a *Clostridioides difficile*, posterior a 48 horas de estancia en la unidad.

Definición de expuestos: Todos los pacientes hospitalizados en Unidad de Cirugía especialidades, Medicina 1 y Cirugía general I, sin deposiciones líquidas ni infección gastrointestinal por *Clostridioides difficile* diagnosticada previo a su ingreso, **28 de junio 2025**.

La curva epidémica se presenta en el siguiente gráfico:

Figura N° 1: Curva epidémica según semana epidemiológica



Intervenciones realizadas

El Programa de Control de Infecciones instruye mediante correo electrónico y Mediante Acta reunión con jefaturas de servicios involucrados del día 10 de junio 2025 (Anexo 3):

- ✚ La totalidad de los pacientes TCD (+) deben ser trasladados y sectorizados en Medicina 1.
- ✚ Se refuerza que el Personal clínico que preste atención directa pacientes TCD +, debe ser exclusivo y no prestar atención a otros pacientes. De requerirse, reforzar y autorizar turnos con mayor personal disponible. En el caso de médicos o profesionales de apoyo como kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, curaciones avanzadas, interconsultores, etc, deben ordenar la secuencia de atención de pacientes, dejando al inicio a pacientes sin síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* y al final, a pacientes con síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* activa.
- ✚ Funcionarios de Medicina 1, no deberán realizar rotación, hasta que finalice el brote.
- ✚ Todo paciente con síndrome diarreico sin causa conocida debe realizarse testeo oportuno para estudio y toma de Toxina A-B (*Clostridioides difficile*).
- ✚ Pauta de supervisión aplicada por personal de enfermería una vez por turno, dicha aplicación es responsabilidad de la jefatura de enfermería.
- ✚ Termómetros, mangos de presión, patos, chatas, etc., de uso individual. Deben ser desinfectados con solución clorada 0.5%.
- ✚ Higienización de manos del personal de salud, deberá ser con agua y jabón cada vez que se tenga contacto con el paciente o la unidad del paciente para lograr por medio de arrastre mecánico para la eliminación de las esporas. Esto deberá ser en los 5 momentos instruidos por la OMS, haciendo énfasis antes y después de tener contacto con paciente y su unidad.
- ✚ Uso de EPP correspondientes para la precaución (guantes y pechera manga larga).
- ✚ Orden de retiro de EPP: sin retirar los guantes, el delantal se retira envolviendo la cara externa y enrollándose hasta colocarlo dentro del guante para eliminarlo. Posteriormente se realiza lavado de mano. Este procedimiento evita contaminar el ambiente y la ropa (tipo de mecanismo de transmisión, esporicida).
- ✚ Se debe mantener supervisión estricta de uso de EPP por parte de todo el personal de clínico y que acuda a la unidad. Cabe destacar que la supervisión del cumplimiento de esto no solo atañe a Jefaturas médicas y de enfermería, sino que es responsabilidad de todo el personal de salud clínico supervisar el correcto cumplimiento del uso de EPP y desinfectantes. (solución clorada al 0.5%).

PRECAUCIÓN ADICIONAL:

- ✚ Se refuerza que la correcta administración de tratamiento antibiótica (totalidad de dosis diarias) asociada a síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* es responsabilidad médica y de enfermería, por lo que se debe realizar revisión diaria a su administración y registro.
- ✚ El registro de la caracterización de las deposiciones es de suma importancia, para evidenciar el resultado ante tratamiento antibiótico y la declaración de las IAAS.
- ✚ Mantener a pacientes en habitación individual o en cohorte con acceso a baño exclusivo.

- ✚ Los pacientes con diagnóstico de TCD +, finalizado el tratamiento efectivo y periodo de observación de 72 horas posterior a este, deberá permanecer con precaución adicional de contacto hasta su alta hospitalaria y hasta 8 semanas posterior al cuadro.
- ✚ En el caso de pacientes con TCD catalogados como RECIDIVA, se mantendrán con precaución adicional de contacto en habitación individual o cohorte según se encuentren con cuadro diarreico activo o sin diarrea, hasta su alta hospitalaria.
- ✚ Los Pacientes contactos de casos positivos de TCD +, se mantendrán en su servicio con precaución de contacto en cohorte por 72 horas en observación posterior a la separación con el caso. Se levantará el aislamiento siempre y cuando no hayan presentado deposiciones líquidas dentro de estas 72 horas de observación.
- ✚ Todo paciente con síndrome diarreico sin causa conocida o con GDH + (y TCD NEGATIVO) se deberá manejar con precaución adicional de contacto en su unidad, hasta 72 horas del cese de síntomas
- ✚ En habitación o unidad con pacientes que cursen síndrome diarreico sin causa conocida o con GDH + (TCD-), se deberán identificar con su respectiva señalética hospitalaria y letrero institucional.
- ✚ Pacientes que cursaron síndrome diarreico por *Clostridioides difficile*, permanecerán con precaución adicional por contacto en su unidad hasta su alta hospitalaria.
- ✚ Pacientes que cursaron síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* y que presenten reingreso por síndrome diarreico hasta 8 semanas posterior al diagnóstico, debe manejarse con precaución adicional por contacto en habitación individual y ser incluidos en reporte de PAE como sospecha de TCD, PCI los evaluara para determinar si corresponde a nueva infección o recidiva del cuadro anterior.
- ✚ Incluir en reporte de precaución adicionales a todos los pacientes que presenten síndrome diarreico sin causa conocida y/o GDH + (TCD).
- ✚ Se mantendrá separación al menos 1 metro entre pacientes.
- ✚ Cada unidad de paciente se considerará como un aislamiento individual por lo cual el personal de salud deberá cambiarse guantes de procedimiento y delantal desechable y higienización de manos con agua y jabón después de la atención de cada paciente.
- ✚ En caso de que el paciente deba ser trasladado a otra institución, debe estar identificado como caso positivo para TCD o contacto de caso positivo, días de tratamiento, días de observación, características y frecuencia de las deposiciones y que paciente pertenece a brote de TCD.
- ✚ Se debe mantener supervisión estricta de uso de EPP.

OIRS:

- ✚ Visitas de pacientes con síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* y contactos restringidos, solo se permite el ingreso de el tutor de estos que se encuentren sectorizados (cohorte), estos deben ser capacitados con respecto del uso correcto de EPP, lavado de manos y precaución de contacto, y deben ser supervisados por todo el personal clínico a cargo.

RAD:

- ✚ Se suspende actividad docente de pregrado, en habitaciones de pacientes síndrome diarreico por *Clostridioides difficile* y en las salas de sus contactos.

Aseo y ropería:

Habitaciones en donde se encuentren los pacientes pertenecientes al brote y sus contactos y en la totalidad de los servicios, en donde se encuentren pacientes TCD (+)

- ✚ La realización de los aseos deberá ser cada 8 horas. El desinfectante para utilizar será solución clorada al 0.5% de concentración, con vigencia de 24 horas desde su preparación, previa limpieza con agua y jabón (según manual de IAAS versión 6).
- ✚ Realizar aseo de superficies por parte del personal auxiliar de la unidad (asear y desinfectar mesas, veladores, barandas, bombas y porta sueros) de cada unidad de paciente con solución clorada al 0.5% al menos 3 veces al día (cada 8 horas). Instalar en puerta registro de la realización de estos con nombre, horario, fecha y firma del responsable (funda plástica).
- ✚ Disponer registro de aseos por SC. Esta planilla de seguimiento de aseos se instalará en puerta de habitación, en funda plástica, siendo el aseo registrado con hora y firma de responsable.
- ✚ Se debe realizar retiro de cortinas en las unidades que cuenten con pacientes TCD +, contactos con casos positivos.
- ✚ Una vez el paciente positivo haya sido trasladado a otra unidad, o bien, haya sido dado de alta, el personal asignado debe deberá realizar aseo terminal de la habitación.
- ✚ Personal clínico deberá realizar revisión de aseo y firmar en caso de conformidad, hoja de chequeo. En caso de inconformidad, solicitar nuevo aseo.
- ✚ Se refuerza que la ropa de cama debe salir de la sala en bolsa plástica transparente, rotulada con la cantidad + la etiqueta de "PAE contacto" escrita en el rotulo.
- ✚ Desechos son asimilables a domiciliarios.

Alimentación:

- ✚ Utensilios como vajilla en habitaciones en donde se encuentren casos TCD +, contactos de casos +, deberá ser desechable y eliminarse dentro de la habitación.
- ✚ El personal de alimentación SI debe ingresar a los servicios de hospitalizados, pero NO deben ingresar a las habitaciones donde se encuentren casos TCD + y contactos de casos, la alimentación debe ser entregada al personal clínico.

Traslado

- ✚ En el caso que los pacientes TCD + o contactos TCD que requieran ser trasladados desde su habitación a un procedimiento (TAC, imágenes, diálisis, entre otros), deben ser el personal clínico a cargo del el que realice este traslado. Se refuerza que, en orden de solicitud de imagenología, se debe identificar si el paciente cuenta con PAE, en el caso de paciente perteneciente a brote TCD (casos + y contacto), registrar "PAE de contacto BROTE".

Fallecidos:

- ✚ Manejo de paciente con PAE de contacto.
- ✚ En cuanto a la ropa clínica (sólo sábanas), deben ser separados y rotulados con "PAE de contacto".

- ✦ Para la realización del aseo del equipamiento médico utilizado en el transporte y conservación de fallecidos, es necesario la utilización de solución clorada al 0.5%.

SEA Observación 4:

- ✦ No mantener pacientes con síndrome diarreico por Clostridioides difficile en boxs de Observación 4, ya que en este espacio no contamos con las condiciones necesarias para el manejo de estos usuarios.

Laboratorio:

- ✦ Se enviará código nacional de brote una vez que sea asignado para su posterior derivación a ISP.

Los resultados reportados por la unidad clínicas involucradas en el brote, ante la aplicación de la pauta "porcentaje de pacientes con infección activa por *Clostridiode difficile* TOXINA A o B (+) que cumplen con el manejo y las medidas de mitigación de diseminación del microorganismo según las directrices instauradas por PCI" son los siguientes:

MES	Unidad	Cumple	Total Evaluados	% de cumplimiento
Junio	Cirugía General	70	115	60.8%
Julio		8	12	66.6%
Agosto		26	31	83.8%

MES	Unidad	Cumple	Total Evaluados	% de cumplimiento
Junio	Cirugía Especialidades	24	30	80%
Julio		48	62	77.4%
Agosto		3	3	100%

MES	Unidad	Cumple	Total Evaluados	% de cumplimiento
Junio	Medicina	10	17	59%
Julio		53	68	78%
Agosto		NO REPORTADO	NO REPORTADO	NO REPORTADO

De los incumplimientos pesquisados por las unidades se describen las más frecuentes:

- **Incumplir con la correcta administración de tratamiento antibiótico.**
- **No contar con correcto registro de deposiciones incluyendo frecuencia, cantidad y características.**
- **No contar con registro de aseo recurrente de superficies de unidad cada 8 horas presente en puerta de sala y firmado acorde a horario correspondiente, por el personal clínico y de concesionaria.**
- **No contar con instauración de precaución adicional en cohorte.**

Los servicios clínicos realizan diariamente y refuerzan correcta practicas clínicas, además de Educaciones programadas para el mes de junio.

Fechas de Hitos:

- ✚ Detección de brote: 10-07-2025
- ✚ Caso índice: 07-07-2025
- ✚ Caso primario: 28-06-2025
- ✚ Inicio de brote (exposición): 28-06-2025
- ✚ Registro de brote en SICARS: 11-07-2025
- ✚ Validación de brote en SICARS: 14-07-2025
- ✚ Autorización de brote en SICARS: 14-07-2025
- ✚ Cierre de brote: 09-08-2025
- ✚ Registro de cierre brote en SICARS: 13-08-2025

Desenlace

Tras trascurridas cuatro semanas, desde la semana epidemiológica 29 a la 32, con un número de casos nuevos dentro de la endemia (Endemia local 0.63 aproximado a 1 caso semanal), se da como Finalizado Brote Epidemiológico por *Clostridioide difficile*.

Letalidad

No se presentan pacientes fallecidos en este brote.

Tabla Cálculo de letalidad asociada a brote Infección gastrointestinal por *Clostridioide difficile*.

Total Fallecidos	0
Total muertes auditadas	0
Total Casos	9
Muerte asociada (A+B*)	0
Letalidad Asociada	0 %
Numero de Expuestos	824

*La infección intrahospitalaria contribuyó a la muerte sin ser causa de ella.

CONCLUSIÓN

Desde la detección del brote al cierre de éste, se presentaron 9 casos de Infección gastrointestinal por *Clostridioide difficile*. De estos casos se generan 54 pacientes “contactos”, 2 de ellos expuestos dos veces, de los cuales ninguno de ellos se positivizó posterior a su separación con caso índice.

Respecto al tratamiento antibiótico efectuado, la totalidad de los pacientes positivos completan tratamiento antibiótico.

Se continúa manteniendo las medidas de prevención para pacientes *Clostridioide difficile* en las distintas unidades clínicas de la institución, capacitaciones de prevención de transmisión de IAAS, utilización correcta de EPP con pasos prácticos, e higiene de manos y bioluminiscencia.

Respecto a las brechas identificadas en la aplicación de pautas de supervisión por las unidades clínicas involucradas en pacientes con Infección por *Clostridioide difficile*, se mantiene el refuerzo en la totalidad del personal, tanto en su supervisión a través de estas pautas, como en la revisión diaria por parte del PCI.

Cobra vital relevancia reporte diario de precauciones adicionales al estándar que es enviado a PCI desde las distintas unidades clínicas de nuestra institución. Cada reporte es analizado por Enfermera perteneciente al Programa Control de Infecciones, para finalmente generar un informe de Precauciones Adicionales Hospitalario diario, este se envía a distintos actores involucrados en el proceso de prevención de IAAS, como Unidad de Operaciones y encargados de aseo intrahospitalario, Sociedad Concesionaria, Gestión del Cuidado y Gestión del Paciente, entre otros, lo que permite tener en conocimiento los distintos microorganismos transmisibles, así como aquellos que se encuentran en aislamiento por Toxina AB, ayudando a prevenir transmisiones, y complementando la información entregada por la Unidad de Microbiología mediante la plataforma oficial utilizada, la cual es revisada diariamente por PCI para mantener el control de las infecciones detectadas.

Además, el Programa Control de Infecciones realiza capacitaciones mensuales informadas desde inicios del 2025, a las que pueden asistir todos los funcionarios de la institución, en donde se refuerzan las medidas de prevención de IAAS, se envían las fechas que un quedan disponibles para el 2025 en correo de cierre de brote. (Anexo 2)

I. ANEXO

Anexo 1: Notificación a Unidad clínica, y se formaliza mediante correo la notificación a Dirección, Subdirecciones, jefes de Servicios, entre otros.

De: IaaS Hec <iaas.hec@redsalud.gob.cl>

Enviado el: jueves, 10 de julio de 2025 17:52

Para: Maria Teresa Chartier Barra <maria.teresa.chartier@redsalud.gob.cl>; BRENDA NICOLE SOTO SANCHEZ <brenda.soto@redsalud.gob.cl>; Erick Iván López Paredes <erick.lopez@redsalud.gob.cl>; Nicole Riquelme Zuñiga <nicole.riquelme@redsalud.gob.cl>; Ana Araya Andrade <ana.araya@redsalud.gob.cl>; Ignacio Valverde Meyer <ignacio.valverde@redsalud.gob.cl>

CC: IaaS Hec <iaas.hec@redsalud.gob.cl>; Calidad Hec <calidad.hec@redsalud.gob.cl>; Yadira Perez Paraquemo <yadira.perez@redsalud.gob.cl>; Paola Fernandez Acevedo <paola.fernandez@redsalud.gob.cl>; Clara Gálvez Leal <clara.galvez@redsalud.gob.cl>; Jefes institucional HEC

<jefesinstitucional.hec@redsalud.gob.cl>; Clara Gálvez Leal <clara.galvez@redsalud.gob.cl>; Consuelo Soto Sánchez

<consuelo.soto@redsalud.gob.cl>; Gladys Nicole Chamorro Villarreal <gladys.chamorro@hotmail.com>; Matías Libuy Ríos

<matias.libuy@redsalud.gob.cl>; Natividad Olivares <natividad.olivares@redsalud.gob.cl>; Yasna Veronica Fuica Carriel

<yasna.fuica@redsalud.gob.cl>; Tamara Patricia Figueroa Vargas <tamara.figueroa@redsalud.gob.cl>; Subdirección Gestión del cuidado HEC

<subdirecciongccc.hec@redsalud.gob.cl>; subdireccionmed.hec <subdireccionmed.hec@redsalud.gob.cl>; Macarena Payeros

<macarenapayeros@gmail.com>; Patricia Rubilar <patricia.rubilar@redsalud.gob.cl>; Ariel Aaron Pardo Jiménez <ariel.pardo@redsalud.gob.cl>;

CONSTANZA VILLAGRA SUAZO <constanza.villagra@redsalud.gob.cl>; Myriam Pizarro <myriam.pizarro@redsalud.gob.cl>; María José Bravo Herrera

<mariajosebravoherrera@gmail.com>; Macarena Escobar Armijo <macarena.escobar@redsalud.gob.cl>; Barbara Gabriela Rebolledo Sepulveda

<barbara.rebolledo@redsalud.gob.cl>; Dirección Hec <direccion.hec@redsalud.gob.cl>; Sandra Maturana Barria

<sandra.maturana@redsalud.gob.cl>; Melissa Jiménez Onell <melissa.jimenez@redsalud.gob.cl>

Asunto: Brote epidémico por ICD Medicina/Cirugía Especialidades Julio 2025

Estimados

Junto con saludar, se informa que se declara brote epidémico por infección gastrointestinal por *Clostridioides difficile* (ICD) entre los servicios de Cirugía Especialidades y Medicina 1. Esto dado que hubo un aumento de casos por el agente mencionado:

Casos con nexo epidemiológico analizado por PCT, es por lo anterior que este programa instaure las siguientes medidas:

- La totalidad de los pacientes TCD (+) deben ser trasladados y sectorizados en Medicina 1.
- Se refuerza que el Personal clínico que preste atención directa pacientes TCD 4, debe ser exclusivo y no prestar atención a otros pacientes. De requerirse, reforzar y autorizar turnos con mayor personal disponible. En el caso de médicos o profesionales de apoyo como kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, curaciones avanzadas, interconsultores, etc, deben ordenar la secuencia de atención de pacientes, dejando al inicio a pacientes sin ICD, y al final a pacientes con ICD activa.

Anexo 2: Fecha de capacitaciones mensuales que quedan disponibles para el 2025 del Programa Control de Infecciones.

Cierre Brote Epidémico por ICD Medicina/ Cirugía Especialidades/ Cirugía General.

11

IaaS Hec

Para: Erick Iván López Paredes; Ignacio Valverde Meyer; Nicole Riquelme Zuñiga; Maria Teresa Chartier Barra; miércoles 13-08-2025 14:36

Ana Araya Andrade; Jervinna Rojas Luengo

CC: Subdirección Gestión del cuidado HEC; Paola Francisca Valdivia Narvaez; DOV RAFAEL GRUEN ARDITI; Dirección Hec; Maria Macarena Payeros Gutierrez; RAD Hec; subdireccionmed.hec; Calidad Hec; y 23 usuarios más

➤ No mantener pacientes con ICD en boxes de Observación 4, ya que en este espacio no contamos con las condiciones necesarias para el manejo de estos usuarios.

Responder Responder a todos Reenviar

Se recuerda que el Programa Control de Infecciones realiza capacitaciones mensuales a la que pueden asistir todos los funcionarios de la Institución, de máximo una hora de duración en las siguientes fechas:

- 25-08-2025 14 hrs auditorio
- 30-09-2025 14 hrs auditorio
- 28-10-2025 14 hrs auditorio
- 26-11-2025 14 hrs auditorio
- 30-12-2025 14 hrs auditorio

Favor difundir información enviada y acusar recibo de la información

Reenviar a quienes consideren pertinente

Quedamos atentos.

Saludos cordiales



Programa Control de Infecciones

Dpto. Calidad y Seguridad del Paciente
Fono: (56-2) 26120094 / Anexo MINSAL: 220094
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
Camino Rinconada 1201, Maipú.

Anexo 3: Acta Reunion Jefes de servicios clinicos involucrados, PCI, PROA, Recursos fisicos y Laboratorio Microbiologia.

Ramón Silesón Brote TCD	10/7/25
--------------------------------	----------------

Acta 1

- Inicio semana 27 Epidem.
- Total de 6 casos en 2 semanas
- Nexos epidemiológicos no claros → Se declara brote por aumento de casos
- IAAS plantea sectorización de casos en Medicina por experiencia en manejo de brote de TCD.
- Aislamiento casos en Medicina y Cx Especialidades
- 2 nuevos pacientes en Cx Especialidades, que además son KRM en distintos resistencias (1 NDM, 1 KPC)
- Se solicita personal exclusiva para pacientes TCD
- Buete 445 Pilla Herrera se mueve a Medicina 1.
- Gente como realizará hoy dicho movimiento y el día de mañana se verá el próximo movimiento del 2º paciente TCD a Medicina 1
- Retiro de alcohol gel en Medicina y Cx Especialidades
- Fortificar brote de manos, una cada 8hrs, reducción de contacto.
- Se solicitará número de personal de área de unidades.
- Ases por personal de área y por auxiliares. Ambas c/ 8hrs en clara al O.S.
- Visitas restringidas, puede venir tutor, pero limitar número de personas. Siempre bajo supervisión directa de personal clínico.
- Aliméntase desechable en este tipo de aislamiento, igual que a los contactos
- Debe poder hacer de registro de área a puerta de la habitación
- Se envía a PROA a reunión para valorar pruebas de nexo de causa y uso de primarios relacionado al brote de TCD.

10/7/2025

TCD genera riesgos, por ello las medidas son fundamentales para detener el contagio.

- Medicina si tiene cabida para designar personal exclusivo para atención de pacientes TCD.

- Repasar registro de características de los depósitos más
- Tratamiento sintomático de excreta primario, ante
dudas se solicita IC a microbiología 10 a 14 días
de vacunación vía oral.

- En relación a grupo de vacunados, se solicitará que
pacientes TCD sean los últimos a ser atendidos.

- Sectorización al final de medicina I para pacientes
TCD.

- Pacientes TCD solo ingresan a Medicina I.

- Se solicita reforzar supervisión del personal de E.A.S.

- Algunos de personal no deben realizar atención de
pacientes TCD.

- Servicio de laboratorio y repaso deben ingresar por
sector de consulta, no por puerta trasera.

- Repaso debe salir en bolsa, rotulado en PAE.

- Delimitación de rutas de ingreso de pacientes TCD.

Lista de Asistencia

10/7/2025

Reunión medidas ante brote TCD

- Paola López Lara HCE
- Paula Valencia Novales MEDICINA
- Roberto Gutiérrez Rojas GDP

- ~~Horacio Pardo~~ MEDICINA

- ~~Ignacio Valdez~~ HCE

- ~~Ignacio Rojas~~ UOP

- ~~Madison Ruiz Paraguri~~ JNAS

- ~~Angel Pardo~~

- ~~Helena E. Martínez~~ SPAC

- ~~Alonso Lora~~ SIBEN UOP

- ~~Patricia Quiles Ruiz~~

- ~~Chao Gómez~~ LCOM

- ~~Rafael Rodríguez~~

- ~~Brenda Soto Sánchez~~ MEDICINA

- ~~Ana Sánchez Vera~~ MEDICINA

- ~~Sandra Salgado Andrade~~ HCE

- ~~Ana Araya~~ HQ

- ~~Daniela Muñoz C.~~ HQ

- ~~Nicoló Martínez~~ HQ

- ~~Mario Teresa Charte B~~ MEDICINA